

GUÍA BABY MATHEW IA

Lactancia sin angustia: tus primeros 6 meses

Agarre, frecuencia, molestias comunes, extracción y regreso al trabajo — lo esencial para alimentar a tu bebé con calma y saber cuándo pedir ayuda.

INTRODUCCIÓN

Bienvenida

Nadie te cuenta que la lactancia, siendo natural, también se aprende. Los primeros días suelen llegar con dudas que pesan: ¿está comiendo suficiente?, ¿por qué me duele?, ¿es normal que quiera pecho cada hora? Esta guía existe para que esas preguntas tengan respuesta clara, sin juicios y sin presión.

Aquí encontrarás lo esencial de los primeros seis meses: cómo lograr un buen agarre, qué frecuencia es normal, cómo saber si tu bebé se está alimentando bien, qué hacer ante las molestias más frecuentes, cómo extraer y conservar la leche y cuáles son tus derechos al volver al trabajo en Colombia. Está basada en recomendaciones de la OMS/UNICEF, la Academia Americana de Pediatría (AAP), los CDC y las Guías Alimentarias del ICBF, pero no reemplaza el control de crecimiento y desarrollo ni el criterio de tu pediatra.

> **Cómo usar esta guía:** lee los capítulos 1 a 3 antes del parto o en la primera semana. Ten a la mano el capítulo de señales de alarma (página 8): es el más importante. Y recuerda que alimentar a tu bebé con fórmula o con lactancia mixta también es una decisión válida (capítulo 6).

Contenido

01 Los primeros días: calostro y bajada de leche — pág. 3

02 El agarre y las posiciones — pág. 4

03 ¿Está comiendo suficiente? — pág. 5

04 Molestias frecuentes y cólicos — pág. 6

05 Extracción, conservación y regreso al trabajo — pág. 7

06 Fórmula, lactancia mixta y tu alimentación — pág. 7

07 Señales de alarma — cuándo consultar — pág. 8

08 Checklist: tu kit de lactancia — pág. 8

DÍAS 0 – 7

Los primeros días: calostro y bajada de leche

Qué es esperable

- Los primeros días produces **calostro**: una leche espesa, amarillenta y en poca cantidad, pero muy concentrada en defensas. El estómago del recién nacido es pequeño, así que esa cantidad es justo la que necesita.
- Entre el día 2 y el 5 ocurre la **"bajada de la leche"**: los pechos se sienten más llenos, pesados y calientes, y la leche se vuelve más blanca y abundante.
- Tu bebé pedirá pecho con mucha frecuencia: **8 a 12 tomas en 24 horas**, de día y de noche. No es que "no se llene"; así estimula tu producción.
- Es normal que el bebé pierda algo de peso en los primeros días y lo recupere hacia las 2 semanas de vida. Tu pediatra lo verifica en el control.

Qué priorizar

- **Piel con piel** desde el nacimiento y en los primeros días: ayuda a que el bebé busque el pecho y a regular su temperatura.
- **Libre demanda**: ofrece el pecho cuando el bebé muestre señales de hambre, sin horario rígido.
- Aprende las **señales tempranas de hambre**: se lleva las manos a la boca, gira la cabeza buscando, abre la boca o hace ruiditos de succión. El llanto es una señal tardía: si llegas ahí, cálmalo primero y luego ofrece.
- Pide apoyo en la clínica antes del alta: que alguien observe una toma completa y revise el agarre.

> **Vale la pena saber:** la producción de leche funciona por oferta y demanda. Mientras más vacía y frecuentemente se estimula el pecho, más leche se produce. Por eso, en estas semanas, la frecuencia es tu mejor aliada.

Cuándo pedir una cita (no es urgencia, pero sí revisar)

- Si al día 5 no sientes ningún cambio en tus pechos ni notas que la leche haya aumentado.
- Si tu bebé está muy somnoliento y cuesta despertarlo para comer, o si la piel o los ojos se ven amarillos (ver señales de alarma, página 8).

CAPÍTULO 2

El agarre y las posiciones

Un buen agarre es la base de todo: previene el dolor, ayuda a que el bebé saque bien la leche y protege tu producción. La lactancia puede incomodar los primeros segundos de cada toma, pero **no debería doler durante toda la toma**. Si duele, casi siempre es el agarre.

Cómo se ve un buen agarre

- La boca bien abierta, abarcando **gran parte de la areola**, no solo el pezón.
- Labios hacia afuera, como "boca de pez", y el mentón pegado al pecho.
- Mejillas redondeadas (no hundidas) mientras succiona.
- Escuchas o ves que **traga**, no solo que succiona; el ritmo se vuelve más lento y profundo cuando sale la leche.
- Al terminar, el pezón sale redondeado, no aplanado ni con forma de "labial".

> **Truco práctico:** acerca el bebé al pecho, no el pecho al bebé. Su nariz frente al pezón, espera a que abra bien la boca y llévalo hacia ti con un movimiento firme. Si el agarre quedó superficial, introduce tu dedo meñique por la comisura de su boca para soltar la succión y vuelve a intentar.

Posiciones para probar

Posición	Cómo es	Útil cuando…
Cuna	Bebé acostado de lado sobre tu antebrazo, barriga con barriga	Ya hay buen agarre; la más común
Cuna cruzada	Lo sostienes con el brazo contrario al pecho que ofreces	Los primeros días: da más control de la cabeza
Balón de rugby	Bebé a tu costado, piernas hacia atrás, bajo tu brazo	Después de cesárea, pechos grandes o gemelos
Acostada de lado	Ambos de lado, frente a frente	Para descansar mientras lactas
Biológica / reclinada	Tú semirreclinada, bebé boca abajo sobre tu pecho	Despierta los reflejos de búsqueda del bebé

Si lactas acostada, regresa al bebé a su cuna al terminar. Dormir con el bebé en la cama de adultos, sofás o sillones aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante (AAP).

¿Está comiendo suficiente?

Es la pregunta más frecuente, porque con el pecho no ves cuántos mililitros toma. La buena noticia es que el cuerpo de tu bebé te da señales claras.

Señales de que se está alimentando bien

- **Pañales mojados**: a partir del día 5, alrededor de 6 o más pañales mojados en 24 horas, con orina clara.
- **Deposiciones**: después de los primeros días, las heces se vuelven amarillas, blandas y grumosas. Más adelante, algunos bebés amamantados hacen deposición varias veces al día y otros cada varios días; ambos patrones pueden ser normales si el bebé está bien.
- Se ve satisfecho y relajado después de la mayoría de las tomas, con manos abiertas.
- **Gana peso** de forma adecuada en los controles de crecimiento y desarrollo. Este es el indicador definitivo, y lo interpreta tu pediatra.

Frecuencia por etapa (orientativa)

Edad	Tomas en 24 h	Qué esperar
0 – 4 semanas	8 – 12	Cada 2-3 horas, de día y de noche
1 – 3 meses	7 – 10	Algunos espacian tomas; otros las agrupan en la tarde
3 – 6 meses	6 – 8	Tomas más cortas y eficientes; se distrae más fácil

Rangos de referencia general. Cada bebé tiene su propio ritmo: espaciar tomas o mantener una frecuencia alta son normales si hay buena ganancia de peso.

> **Los "picos de crecimiento":** hay días en los que tu bebé pide pecho casi sin pausa y parece no llenarse. Suelen presentarse en las primeras semanas y alrededor de los 3 meses, y duran unos pocos días. No significan que tu leche "no alimente" ni que se esté acabando: es su forma de aumentar tu producción. Ofrece con frecuencia y descansa lo que puedas.

Mitos frecuentes

- **"Mi leche es aguada"**: la leche cambia durante la toma; al inicio es más líquida y al final más rica en grasa. Por eso conviene dejar que vacíe un pecho antes de ofrecer el otro.
- **"Tengo los pechos blandos, ya no produzco"**: hacia las 6-12 semanas el cuerpo regula la producción y los pechos dejan de sentirse llenos. Es normal.

CAPÍTULO 4

Molestias frecuentes y cólicos

Dolor y grietas en el pezón

- La causa más común es un agarre superficial: revisa el capítulo 2 antes que nada.
- Después de la toma, puedes dejar unas gotas de tu propia leche sobre el pezón y dejar secar al aire.
- Si el dolor persiste más allá de unos días, o hay sangrado, busca un consultor de lactancia o tu IPS.

Pechos congestionados

- Frecuente con la bajada de la leche: pechos duros, tensos y calientes.
- Amamanta con frecuencia. Si la areola está muy dura y el bebé no logra agarrar, extrae un poco de leche antes para ablandarla.
- Frío local entre tomas puede aliviar la inflamación.

Conducto obstruido vs. mastitis

	Conducto obstruido	Posible mastitis
Cómo se siente	Bulto sensible y localizado	Zona roja, caliente y dolorosa
Fiebre / malestar	No	Sí: fiebre, escalofríos, malestar tipo gripa
Qué hacer	Seguir amamantando, variar posiciones, masaje suave	**Consultar a tu médico** el mismo día. No dejes de amamantar salvo indicación médica

No te automediques. Cualquier medicamento durante la lactancia debe indicarlo tu médico tratante.

Cólicos del lactante

Llanto intenso e inconsolable, típicamente al final del día, en un bebé por lo demás sano y que gana peso. Suele empezar hacia las 2-3 semanas y mejorar hacia los 3-4 meses.

- Posición semierguida después de la toma y sacar los gases.
- "Bicicleta" suave con las piernas y masaje abdominal en sentido de las manecillas del reloj.
- Contacto piel con piel, arrullo y un ambiente con poca estimulación.

> **Importante:** si el llanto viene con fiebre, vómito, sangre en las heces, rechazo del alimento o el bebé se ve decaído, no es "solo cólico". Consulta a tu pediatra.

Extracción, regreso al trabajo y fórmula

Conservar la leche extraída (CDC / AAP)

Dónde	Tiempo máximo
Temperatura ambiente (hasta 25 °C)	Hasta 4 horas
Nevera	Hasta 4 días
Congelador	6 a 12 meses (mejor si es de puerta independiente)

- Descongela en la nevera la noche anterior o bajo agua tibia corriente. **Nunca en microondas**: calienta de forma despareja y puede quemar al bebé.
- La leche descongelada no se vuelve a congelar. Ante la duda (olor, tiempo, color), descártala.
- Rotula cada recipiente con la fecha y usa primero la más antigua.

Volver al trabajo en Colombia

- **Licencia de maternidad**: 18 semanas remuneradas (Ley 1822 de 2017).
- **Pausas de lactancia**: durante los primeros 6 meses tienes derecho a dos descansos de 30 minutos al día, sin descuento de salario, para amamantar o extraer leche (Código Sustantivo del Trabajo, art. 238).
- **Salas Amigas de la Familia Lactante**: la Ley 1823 de 2017 obliga a ciertas entidades públicas y empresas privadas a adecuar espacios para extraer y conservar la leche. Pregunta en tu empresa si la tienen.
- Empieza a extraer y congelar 2-3 semanas antes de volver, para tener reserva y practicar.

Verifica las condiciones vigentes con tu empleador o tu EPS. Esta información es general y no es asesoría legal individual.

Fórmula y lactancia mixta: sin culpa

Cuando la lactancia exclusiva no es posible, no alcanza o no es la decisión de la familia, la fórmula infantil es una alternativa adecuada. La lactancia mixta (pecho + fórmula) también es segura. Para preparar el biberón: manos limpias, biberones esterilizados, agua potable y **exactamente la proporción del empaque**. No guardes sobrantes de una toma. El tipo o la marca de fórmula siempre los define tu pediatra.

Tu alimentación mientras lactas (ICBF)

No necesitas una dieta especial: come variado y suficiente, con buena hidratación y alimentos ricos en hierro y calcio. Evita el alcohol y limita la cafeína. No elimines grupos de alimentos "por si acaso" sin consultar.

CAPÍTULOS 7 Y 8

Señales de alarma y tu kit de lactancia

⚠ En tu bebé — consulta de inmediato

- Fiebre (38 °C o más) en menor de 3 meses
- Rechazo total del alimento en varias tomas seguidas, o muy difícil de despertar para comer
- Menos de 3-4 pañales mojados en 24 horas
- Piel u ojos amarillos en las primeras 24 horas de vida, o que se extienden a brazos, piernas, palmas o plantas
- Vómito en proyectil repetido, o con sangre o color verde
- Dificultad para respirar, quejido o color azulado
- Fontanela (mollera) muy hundida o muy abultada

⚠ En ti — consulta pronto

- Fiebre, escalofríos o una zona del pecho roja, caliente y dolorosa
- Grietas con pus o sangrado que no mejoran
- Tristeza persistente, ansiedad intensa o pensamientos de hacerte daño o dañar al bebé

Líneas en Colombia: Emergencias 123 · Apoyo en salud mental (Minsalud) 192, opción 4. Ante cualquiera de estas señales, acude a urgencias o contacta a tu médico. No esperes a que "se pase".

Checklist: tu kit de lactancia

- [ ] Una almohada o cojín de lactancia para apoyar al bebé y tus brazos
- [ ] Brasieres de lactancia cómodos, sin varillas
- [ ] Protectores o pañitos absorbentes para el pecho
- [ ] Botella de agua y snacks al alcance de la mano
- [ ] Sacaleches (manual o eléctrico) si vas a extraer, y recipientes o bolsas para congelar
- [ ] Marcador para rotular fechas
- [ ] El contacto de un consultor de lactancia, tu IPS o un grupo de apoyo, guardado en tu celular

¿Y después de esta guía?

Cada lactancia es distinta. Baby Mathew IA te acompaña semana a semana, resolviendo tus dudas en el momento en que las tienes, en la gestación y durante los primeros dos años de tu bebé.

Sigue la conversación con Baby Mathew

Pregúntale lo que quieras, cuando quieras, gratis.

bebeteguia.com

Fuentes de referencia

- OMS / UNICEF. Recomendaciones sobre lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses.
- Academia Americana de Pediatría (AAP). Recomendaciones de lactancia, alimentación con fórmula y sueño seguro.
- CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). Extracción y conservación de la leche materna.
- ICBF. Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para mujeres gestantes, madres en período de lactancia y niños menores de 2 años.
- Minsalud Colombia. Resolución 3280 de 2018 (Rutas Integrales de Atención en Salud).
- Ley 1822 de 2017 (licencia de maternidad) · Ley 1823 de 2017 (Salas Amigas de la Familia Lactante) · Código Sustantivo del Trabajo, art. 238.

Esta guía es material informativo general. No sustituye la consulta, el diagnóstico ni el tratamiento de un profesional de la salud. Ante cualquier duda sobre tu lactancia o la salud de tu bebé, consulta siempre a tu pediatra o médico tratante, o acude al servicio de urgencias.

© Baby Mathew IA — bebeteguia.com